JEU DE 52 CARTES + 2 JOKERS · ÉTUDIANTS IPA, MENTION URGENCES

Raisonnement clinique IPA · Urgences

Un jeu de 52 cartes pour la mention « Urgences ». Chaque couleur correspond à une étape du raisonnement clinique, chaque valeur à une situation clinique suivie à travers un même patient. Chaque carte indique les compétences IPA qu'elle mobilise. Réunir les quatre cartes d'une valeur, c'est dérouler un raisonnement complet, du recueil des données à la coordination du parcours.

Les 4 couleurs = 4 étapes

- ♥ **Cœur — Recueillir**
  Anamnèse, écoute, contexte de vie
- ♦ **Carreau — Repérer & hypothèses**
  Repérage, scores, hypothèses et drapeaux rouges
- ♣ **Trèfle — Vérifier**
  Examen clinique, examens complémentaires, diagnostics différentiels
- ♠ **Pique — Agir & suivre**
  Projet de soins, prévention, ETP, parcours et coordination

Les 13 valeurs = 13 situations

2	Douleur thoracique
3	Traumatisme de la cheville
4	Plaie de la main
5	Céphalée brutale
6	Lombalgie aiguë
7	Infection urinaire
8	Traumatisme crânien sous anticoagulant
9	Brûlure
10	Asthme aigu
V	Chute de la personne âgée
D	Intoxication alcoolique aiguë
R	Colique néphrétique
A	Passages répétés : parcours

Anatomie d'une carte

Vignette (situation du patient, qui évolue d'une couleur à l'autre) · **Question** posée au joueur · **Repères attendus**, lus uniquement par celui qui pose la question pour valider la réponse. Les repères ne sont pas exhaustifs : une argumentation pertinente non listée est valorisée.

Mode 1 · Le Carré clinique

3 à 6 joueurs · 45 à 60 min

1. Distribuer 6 cartes par joueur ; le reste forme la pioche.
2. À son tour, un joueur demande à un autre une carte précise pour avancer un carré (« le Trèfle de la céphalée »).
3. Si l'autre la possède, il lit la vignette et la question ; le demandeur répond. Réponse validée au regard des repères → il prend la carte et rejoue. Sinon, ou si la carte n'est pas en jeu, il pioche et la main passe.
4. Carré complet : le joueur le pose et présente en 2 minutes une **synthèse orale** du raisonnement (recueil → hypothèses → vérification → action) : **4 points**. +1 point s'il le relie à une autre thématique (chute et traumatisme crânien, alcool et RPIB…).
5. Fin de partie quand la pioche est vide : le plus de points l'emporte.

Les jokers

Drapeau rouge et **Leadership & recherche** remplacent une carte manquante d'un carré, à condition de relever le défi inscrit dessus.

Mode 2 · Le Fil rouge

Travaux dirigés · groupes de 4 à 8 · 20 min par cas

L'animateur extrait les 4 cartes d'une situation et les révèle dans l'ordre ♥ ♦ ♣ ♠. Le groupe raisonne à voix haute à chaque étape avant de découvrir la suivante, puis compare avec les repères.

Mode 3 · Le Tirage éclair

Révision en binôme · 10 à 15 min

Mélanger, tirer une carte, lire la vignette et la question ; le partenaire répond en 1 minute. Comparer aux repères, puis inverser les rôles.

Pistes de débriefing

- Hiérarchisation des hypothèses, drapeaux rouges
- Biais cognitifs : ancrage, fermeture prématurée
- Place du patient : préférences, littératie, décision partagée
- Cadre d'exercice IPA : ce qui relève de l'IPA, de la concertation, de l'orientation

Impression : A4, recto verso (retournement bord long), échelle 100 %, papier 250 à 300 g/m² ; découper le long des repères de coupe. Pages impaires = faces, pages paires = dos.
Avertissement : contenus fondés sur les recommandations connues en octobre 2026 (HAS, sociétés savantes, référentiels de la mention), sans vérification en ligne carte par carte ; les cas sont illustratifs. Les conduites thérapeutiques s'entendent dans le cadre des protocoles et de la réglementation en vigueur. À vérifier et actualiser par l'équipe pédagogique avant usage.

MENTION URGENCES

Compétences et situations

La mention urgences couvre l'accueil, l'évaluation et l'orientation des patients consultant aux urgences : repérage des situations graves et des drapeaux rouges, prise en charge des motifs de recours courants selon les protocoles, prévention et repérage (alcool, chutes, vaccination), et organisation de la sortie et du parcours d'aval.

Les 6 compétences IPA mobilisées

Code	Compétence	Où dans le jeu
C1	Évaluer l'état de santé de patients en relais de consultations médicales pour des pathologies identifiées	♥ ♦ ♣
C2	Définir et mettre en œuvre le projet de soins du patient à partir de l'évaluation globale de son état de santé	♣ ♠
C3	Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention et d'éducation thérapeutique	♦ ♠
C4	Organiser les parcours de soins et de santé en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés	♠
C5	Mettre en place et conduire des actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques en exerçant un leadership clinique	Joker 2, repères ♠
C6	Rechercher, analyser et produire des données professionnelles et scientifiques	Joker 2, débriefing

Chaque carte porte en en-tête les compétences qu'elle mobilise en priorité. Les compétences C5 et C6 sont travaillées avec le joker « Leadership & recherche » et lors du débriefing.

Les 13 situations cliniques

2	**Douleur thoracique**	M. C., 52 ans, fumeur, consulte aux urgences pour une douleur thoracique qui dure depuis 1 heure.
3	**Traumatisme de la cheville**	Léo, 25 ans, s'est tordu la cheville au football. Il marche difficilement.
4	**Plaie de la main**	Mme B., 46 ans, s'est coupé la paume avec un couteau de cuisine il y a 2 heures.
5	**Céphalée brutale**	Mme T., 38 ans, consulte pour une céphalée intense survenue brutalement en soulevant une charge.
6	**Lombalgie aiguë**	M. L., 42 ans, consulte pour une lombalgie apparue il y a 2 jours en portant un meuble.
7	**Infection urinaire**	Mme U., 32 ans, consulte pour des brûlures mictionnelles et des envies fréquentes d'uriner depuis 24 heures.
8	**Traumatisme crânien sous anticoagulant**	M. V., 78 ans, sous anticoagulant pour une FA, a chuté et s'est cogné la tête.
9	**Brûlure**	Lina, 30 ans, s'est brûlé l'avant-bras avec de l'eau bouillante il y a 30 minutes.
10	**Asthme aigu**	Malik, 22 ans, asthmatique, consulte pour une gêne respiratoire depuis la veille.
V	**Chute de la personne âgée**	Mme A., 84 ans, vit seule. Sa voisine l'a retrouvée au sol, où elle a passé la nuit.
D	**Intoxication alcoolique aiguë**	Romain, 19 ans, est amené par ses amis après une soirée. Il est somnolent et a beaucoup bu.
R	**Colique néphrétique**	M. N., 35 ans, consulte pour une douleur lombaire droite brutale et intense, irradiant vers l'aine.
A	**Passages répétés : parcours**	Mme H., 66 ans, BPCO, consulte pour la quatrième fois en 2 mois aux urgences pour dyspnée.

2 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Douleur thoracique

Compétences IPA : C1

> *M. C., 52 ans, fumeur, consulte aux urgences pour une douleur thoracique qui dure depuis 1 heure.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Siège, type (constrictive), irradiation, durée, lien avec l'effort
- Dyspnée, sueurs, nausées, malaise
- Facteurs de risque cardiovasculaire
- Antécédents cardiaques, traitements
- PA aux deux bras, FC, SpO_2

Raisonnement clinique · IPA URG

♥ 2

2 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Douleur thoracique

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. C., 52 ans, fumeur, consulte aux urgences pour une douleur thoracique qui dure depuis 1 heure.

> *Douleur constrictive irradiant dans le bras gauche, sueurs.*

? Quelles hypothèses formulez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Syndrome coronarien aigu : priorité absolue
- Autres urgences : dissection aortique, embolie pulmonaire, péricardite, pneumothorax
- ECG dans les 10 minutes
- Niveau de tri élevé

Raisonnement clinique · IPA URG

♦ 2

2 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Douleur thoracique

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. C., 52 ans, fumeur, consulte aux urgences pour une douleur thoracique qui dure depuis 1 heure.

> *ECG : sus-décalage du segment ST en territoire inférieur.*

? Quels examens ? Quelle urgence ?

REPÈRES ATTENDUS

- SCA avec sus-décalage : alerte médicale immédiate, filière de reperfusion
- Troponine, NFS, ionogramme, hémostase
- Monitorage, voie veineuse
- Reperfusion le plus tôt possible

Raisonnement clinique · IPA URG

♣ 2

2 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Douleur thoracique

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. C., 52 ans, fumeur, consulte aux urgences pour une douleur thoracique qui dure depuis 1 heure.

> *Le patient part en salle de coronarographie.*

? Quel est votre rôle et quel suivi ?

REPÈRES ATTENDUS

- Coordination de la filière, traçabilité des délais
- Information du patient et des proches
- Après l'épisode : prévention secondaire (tabac, réadaptation cardiaque)
- Suivi des délais porte-ECG et porte-reperfusion (indicateurs qualité)
- Retour d'expérience en équipe

Raisonnement clinique · IPA URG

♠ 2

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

3 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Traumatisme de la cheville

Compétences IPA : C1

> *Léo, 25 ans, s'est tordu la cheville au football. Il marche difficilement.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Mécanisme (inversion), craquement, douleur immédiate
- Capacité à faire 4 pas, juste après et aux urgences
- Antécédents d'entorse
- Douleur (EN)
- Activité professionnelle et sportive

Raisonnement clinique · IPA URG

♥ 3

3 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Traumatisme de la cheville

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Léo, 25 ans, s'est tordu la cheville au football. Il marche difficilement.

> *Douleur à la palpation du bord postérieur de la malléole latérale ; impossible de faire 4 pas.*

? Quelle règle appliquez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Règles d'Ottawa : radiographie indiquée
- Critères : douleur au bord postérieur ou à la pointe d'une malléole, à la base du 5e métatarsien ou au naviculaire, ou impossibilité de faire 4 pas
- Hypothèses : entorse ou fracture malléolaire
- Gravité de l'entorse à évaluer

Raisonnement clinique · IPA URG

♦ 3

3 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Traumatisme de la cheville

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Léo, 25 ans, s'est tordu la cheville au football. Il marche difficilement.

> *Radiographie normale.*

? Comment évaluez-vous l'entorse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Entorse du ligament collatéral latéral
- Œdème, ecchymose, laxité (réévaluée à J3–J5)
- Lésions associées : base du 5e métatarsien, tendons fibulaires
- Examen vasculo-nerveux

Raisonnement clinique · IPA URG

♣ 3

3 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Traumatisme de la cheville

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Léo, 25 ans, s'est tordu la cheville au football. Il marche difficilement.

> *Entorse de gravité moyenne.*

? Quelle prise en charge proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Repos relatif, glace, compression, élévation ; antalgiques
- Orthèse stabilisatrice, appui selon la douleur
- Rééducation proprioceptive précoce
- Consignes de réévaluation, signes d'alerte
- Arrêts de travail et de sport adaptés

Raisonnement clinique · IPA URG

♠ 3

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

4 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Plaie de la main

Compétences IPA : C1

> *Mme B., 46 ans, s'est coupé la paume avec un couteau de cuisine il y a 2 heures.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Circonstances, objet, délai, souillure
- Statut vaccinal antitétanique
- Diabète, anticoagulants, immunodépression
- Main dominante, profession
- Allergies

Raisonnement clinique · IPA URG

4 ♥

4 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Plaie de la main

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme B., 46 ans, s'est coupé la paume avec un couteau de cuisine il y a 2 heures.

> *Plaie de 2 cm, peu profonde. Dernier rappel antitétanique il y a 15 ans.*

? Quelles hypothèses ? Quels risques ?

REPÈRES ATTENDUS

- Plaie simple à confirmer : aucune atteinte tendineuse, nerveuse ou vasculaire
- Plaie de la main : exploration rigoureuse
- Vaccination antitétanique non à jour
- Risque infectieux faible si plaie propre

Raisonnement clinique · IPA URG

4 ♦

4 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Plaie de la main

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme B., 46 ans, s'est coupé la paume avec un couteau de cuisine il y a 2 heures.

> *Vous examinez la main.*

? Que vérifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Flexion et extension de chaque doigt (tendons)
- Sensibilité des pulpes (nerfs digitaux)
- Recoloration
- Corps étranger dans la plaie

Raisonnement clinique · IPA URG

4 ♣

4 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Plaie de la main

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme B., 46 ans, s'est coupé la paume avec un couteau de cuisine il y a 2 heures.

> *Pas de lésion profonde.*

? Quelle prise en charge proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Lavage, parage, suture ou colle
- Rappel antitétanique ± immunoglobulines selon le statut et le type de plaie
- Pansement, conseils, date d'ablation des fils
- Signes d'infection à surveiller
- Avis SOS Main en cas de doute

Raisonnement clinique · IPA URG

4 ♠

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

5 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Céphalée brutale

Compétences IPA : C1

> *Mme T., 38 ans, consulte pour une céphalée intense survenue brutalement en soulevant une charge.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Mode d'installation : brutal ou progressif
- Antécédents de céphalées, migraine
- Vomissements, raideur de nuque, fièvre, signes neurologiques
- Traitements, anticoagulants
- Grossesse, post-partum

Raisonnement clinique · IPA URG

5 ♥

5 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Céphalée brutale

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme T., 38 ans, consulte pour une céphalée intense survenue brutalement en soulevant une charge.

> *Céphalée maximale en moins d'une minute, « la pire de ma vie ».*

? Quelle hypothèse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Céphalée en coup de tonnerre : hémorragie méningée jusqu'à preuve du contraire
- Autres : dissection artérielle, vasoconstriction cérébrale réversible
- Drapeaux rouges des céphalées
- Bilan immédiat

Raisonnement clinique · IPA URG

5 ♦

5 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Céphalée brutale

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme T., 38 ans, consulte pour une céphalée intense survenue brutalement en soulevant une charge.

> *Examen neurologique normal.*

? Quels examens ?

REPÈRES ATTENDUS

- Scanner cérébral sans injection en urgence
- Ponction lombaire si scanner normal et suspicion forte
- Angio-imagerie selon le contexte
- Surveillance neurologique

Raisonnement clinique · IPA URG

5 ♣

5 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Céphalée brutale

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme T., 38 ans, consulte pour une céphalée intense survenue brutalement en soulevant une charge.

> *Hémorragie méningée confirmée.*

? Quel est votre rôle ?

REPÈRES ATTENDUS

- Alerte, coordination avec la neurochirurgie et la neuroradiologie
- Surveillance : conscience, PA, douleur
- Information de la patiente et des proches
- Traçabilité
- Analyse de cas sur l'application des drapeaux rouges

Raisonnement clinique · IPA URG

5 ♠

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

6 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Lombalgie aiguë

Compétences IPA : C1

M. L., 42 ans, consulte pour une lombalgie apparue il y a 2 jours en portant un meuble.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Mécanisme, horaire de la douleur, irradiation
- Drapeaux rouges : fièvre, amaigrissement, cancer, traumatisme, troubles sphinctériens
- Drapeaux jaunes : peur, catastrophisme, difficultés au travail
- Traitements essayés
- Profession

♥ 9

6 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Lombalgie aiguë

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. L., 42 ans, consulte pour une lombalgie apparue il y a 2 jours en portant un meuble.

Douleur mécanique, sans irradiation, sans drapeau rouge.

? Quelle hypothèse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Lombalgie commune aiguë
- Pas d'imagerie indiquée
- Évolution favorable en quelques semaines dans la majorité des cas
- Facteurs de chronicisation à repérer

♦ 9

6 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Lombalgie aiguë

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. L., 42 ans, consulte pour une lombalgie apparue il y a 2 jours en portant un meuble.

Il réclame une radiographie.

? Que vérifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Examen neurologique : déficit, réflexes
- Syndrome de la queue de cheval : anesthésie en selle, troubles urinaires
- Ses attentes et ses craintes
- Risque de chronicité (STarT Back)

♣ 9

6 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Lombalgie aiguë

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. L., 42 ans, consulte pour une lombalgie apparue il y a 2 jours en portant un meuble.

Lombalgie commune confirmée.

? Quelle prise en charge ?

REPÈRES ATTENDUS

- Expliquer pourquoi l'imagerie n'est pas utile
- Maintien de l'activité, pas de repos au lit
- Antalgiques simples
- Arrêt de travail court si nécessaire
- Consignes : drapeaux rouges, réévaluation si pas d'amélioration

♠ 9

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

7 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Infection urinaire

Compétences IPA : C1

> *Mme U., 32 ans, consulte pour des brûlures mictionnelles et des envies fréquentes d'uriner depuis 24 heures.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Signes urinaires, fièvre, douleurs lombaires
- Grossesse possible ?
- Antécédents d'infections ou d'anomalies urinaires
- Allergies
- Facteurs de risque de complication

7 ♥

7 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Infection urinaire

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme U., 32 ans, consulte pour des brûlures mictionnelles et des envies fréquentes d'uriner depuis 24 heures.

> *Pas de fièvre, pas de douleur lombaire, pas de grossesse.*

? Quelle hypothèse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Cystite aiguë simple
- Différentiels : vaginite, IST
- Bandelette urinaire
- Aucun facteur de risque de complication

7 ♦

7 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Infection urinaire

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme U., 32 ans, consulte pour des brûlures mictionnelles et des envies fréquentes d'uriner depuis 24 heures.

> *Bandelette positive (leucocytes et nitrites).*

? Faut-il un ECBU ?

REPÈRES ATTENDUS

- Non pour une cystite simple
- ECBU si cystite à risque de complication, récidive, échec ou grossesse
- Bandelette négative : chercher un autre diagnostic
- Fièvre ou douleur lombaire → pyélonéphrite : ECBU

7 ♣

7 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Infection urinaire

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme U., 32 ans, consulte pour des brûlures mictionnelles et des envies fréquentes d'uriner depuis 24 heures.

> *Cystite simple confirmée.*

? Quelle prise en charge ?

REPÈRES ATTENDUS

- Fosfomycine-trométamol en dose unique en 1re intention, selon protocole
- Hydratation, mictions régulières
- Signes d'alerte : fièvre, douleur lombaire
- Pas d'examen de contrôle si évolution favorable
- Prévention des récidives

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

8 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Traumatisme crânien sous anticoagulant

Compétences IPA : C1

M. V., 78 ans, sous anticoagulant pour une FA, a chuté et s'est cogné la tête.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Circonstances, perte de connaissance, amnésie
- Anticoagulant, heure de la dernière prise
- Céphalées, vomissements, confusion
- Score de Glasgow
- Cause de la chute

♥ 8

Raisonnement clinique · IPA URG

8 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Traumatisme crânien sous anticoagulant

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. V., 78 ans, sous anticoagulant pour une FA, a chuté et s'est cogné la tête.

Glasgow 15, pas de perte de connaissance, céphalée modérée.

? Quels risques identifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Traumatisme crânien léger
- Anticoagulant : risque d'hémorragie intracrânienne
- Âge ≥ 65 ans : autre facteur de risque
- Imagerie indiquée

♦ 8

Raisonnement clinique · IPA URG

8 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Traumatisme crânien sous anticoagulant

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. V., 78 ans, sous anticoagulant pour une FA, a chuté et s'est cogné la tête.

Vous organisez la prise en charge.

? Quels examens ?

REPÈRES ATTENDUS

- Scanner cérébral rapide
- Bilan d'anticoagulation selon la molécule
- Cause de la chute : malaise, hypotension orthostatique
- Autres lésions traumatiques

♣ 8

Raisonnement clinique · IPA URG

8 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Traumatisme crânien sous anticoagulant

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. V., 78 ans, sous anticoagulant pour une FA, a chuté et s'est cogné la tête.

Scanner normal.

? Quelle prise en charge et quelles consignes ?

REPÈRES ATTENDUS

- Surveillance selon le protocole
- Consignes écrites de surveillance pour l'entourage
- Réévaluation de la balance bénéfice-risque de l'anticoagulation avec le médecin traitant
- Programme de prévention des chutes
- Courrier de liaison vers la ville

♠ 8

Raisonnement clinique · IPA URG

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

9 ♥ CŒUR · RECUEILLIR

Brûlure

Compétences IPA : C1

Lina, 30 ans, s'est brûlé l'avant-bras avec de l'eau bouillante il y a 30 minutes.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Agent, durée de contact, refroidissement immédiat
- Surface, localisation
- Douleur
- Vaccination antitétanique
- Antécédents

Raisonnement clinique · IPA URG

♥ 6

9 ♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Brûlure

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Lina, 30 ans, s'est brûlé l'avant-bras avec de l'eau bouillante il y a 30 minutes.

Phlyctènes, fond rose et douloureux ; 2 % de la surface corporelle.

? Comment évaluez-vous la brûlure ?

REPÈRES ATTENDUS

- Brûlure du 2e degré superficiel
- Surface estimée avec la paume de la main (≈ 1 %)
- Pas de critère de gravité
- Prise en charge ambulatoire possible

Raisonnement clinique · IPA URG

♦ 6

9 ♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Brûlure

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Lina, 30 ans, s'est brûlé l'avant-bras avec de l'eau bouillante il y a 30 minutes.

Vous vérifiez les critères de gravité.

? Quels critères recherchez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Surface > 10 % chez l'adulte
- Localisation : visage, mains, pieds, périnée, plis
- Profondeur : 2e degré profond, 3e degré
- Terrain : âges extrêmes, comorbidités

Raisonnement clinique · IPA URG

♣ 6

9 ♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Brûlure

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Lina, 30 ans, s'est brûlé l'avant-bras avec de l'eau bouillante il y a 30 minutes.

Brûlure superficielle sans gravité.

? Quelle prise en charge ?

REPÈRES ATTENDUS

- Refroidissement à l'eau tempérée (environ 15 min) si brûlure récente
- Nettoyage, pansement adapté
- Antalgie
- Mise à jour antitétanique
- Revoir à 48 h ; signes d'infection

Raisonnement clinique · IPA URG

♠ 6

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

10 ♥ CŒUR · RECUEILLIR

Asthme aigu

Compétences IPA : C1

Malik, 22 ans, asthmatique, consulte pour une gêne respiratoire depuis la veille.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Dyspnée, toux, sifflements
- Traitement de fond et de crise, utilisation réelle
- Facteurs déclenchants
- Antécédents d'asthme grave
- FR, SpO_2, FC

Raisonnement clinique · IPA URG

10 ♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Asthme aigu

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Malik, 22 ans, asthmatique, consulte pour une gêne respiratoire depuis la veille.

Il parle par phrases, SpO_2 94 %, débit expiratoire de pointe à 60 % de la théorique.

? Comment évaluez-vous la gravité ?

REPÈRES ATTENDUS

- Exacerbation modérée
- Gravité : parole difficile, SpO_2 < 92 %, DEP < 50 %, troubles de conscience
- Facteur déclenchant : infection, allergène
- Asthme mal contrôlé

Raisonnement clinique · IPA URG

10 ♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Asthme aigu

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Malik, 22 ans, asthmatique, consulte pour une gêne respiratoire depuis la veille.

Vous traitez et réévaluez.

? Que surveillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- DEP, SpO_2, FR après bronchodilatateurs
- Réponse au traitement à 1 heure
- Signes d'épuisement
- Gaz du sang si gravité

Raisonnement clinique · IPA URG

10 ♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Asthme aigu

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Malik, 22 ans, asthmatique, consulte pour une gêne respiratoire depuis la veille.

Bonne réponse au traitement.

? Quelle prise en charge et quel suivi ?

REPÈRES ATTENDUS

- Bronchodilatateurs et corticoïdes oraux selon protocole
- ETP : technique d'inhalation, plan d'action écrit
- Vérification du traitement de fond
- Consultation de suivi rapide
- Arrêt du tabac

Raisonnement clinique · IPA URG

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Chute de la personne âgée

Compétences IPA : C1

> *Mme A., 84 ans, vit seule. Sa voisine l'a retrouvée au sol, où elle a passé la nuit.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Durée au sol
- Circonstances, malaise, perte de connaissance
- Douleurs, traumatismes
- Traitements
- Autonomie, aides à domicile

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Chute de la personne âgée

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme A., 84 ans, vit seule. Sa voisine l'a retrouvée au sol, où elle a passé la nuit.

> *Station au sol de 8 heures.*

? Quels risques identifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Rhabdomyolyse, déshydratation, hypothermie
- Escarres
- Cause de la chute à rechercher
- Fragilité, risque de récidive

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Chute de la personne âgée

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme A., 84 ans, vit seule. Sa voisine l'a retrouvée au sol, où elle a passé la nuit.

> *Vous organisez le bilan.*

? Quels examens ?

REPÈRES ATTENDUS

- CPK, créatinine, ionogramme
- ECG, glycémie
- Radiographies selon les douleurs
- Évaluation cognitive

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Chute de la personne âgée

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme A., 84 ans, vit seule. Sa voisine l'a retrouvée au sol, où elle a passé la nuit.

> *Pas de fracture. Elle souhaite rentrer chez elle.*

? Comment organisez-vous la sortie ?

REPÈRES ATTENDUS

- Évaluation de l'autonomie et du domicile
- Téléassistance
- Lien avec le médecin traitant et les aides
- Programme de prévention des chutes
- Évaluation gériatrique si possible

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

D ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Intoxication alcoolique aiguë

Compétences IPA : C1

Romain, 19 ans, est amené par ses amis après une soirée. Il est somnolent et a beaucoup bu.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Quantité, type d'alcool, horaire
- Autres substances
- Traumatisme, chute
- Antécédents
- Constantes, glycémie

Raisonnement clinique · IPA URG

♥ D

D ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Intoxication alcoolique aiguë

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Romain, 19 ans, est amené par ses amis après une soirée. Il est somnolent et a beaucoup bu.

Somnolent mais réveillable, Glasgow 13, haleine alcoolique.

? Quelles hypothèses formulez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Intoxication alcoolique aiguë
- Ne pas méconnaître : traumatisme crânien, hypoglycémie, autre intoxication
- Risque d'inhalation
- Surveillance nécessaire

Raisonnement clinique · IPA URG

♦ D

D ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Intoxication alcoolique aiguë

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Romain, 19 ans, est amené par ses amis après une soirée. Il est somnolent et a beaucoup bu.

Vous le surveillez.

? Quels examens et quelle surveillance ?

REPÈRES ATTENDUS

- Glycémie capillaire
- Alcoolémie selon le contexte
- Surveillance neurologique répétée
- Recherche de traumatisme

Raisonnement clinique · IPA URG

♣ D

D ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Intoxication alcoolique aiguë

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Romain, 19 ans, est amené par ses amis après une soirée. Il est somnolent et a beaucoup bu.

Il se réveille.

? Quelle intervention avant la sortie ?

REPÈRES ATTENDUS

- Repérage précoce et intervention brève (RPIB)
- Information sur les risques
- Orientation vers une Consultation Jeunes Consommateurs
- Sortie accompagnée
- Lien avec l'entourage

Raisonnement clinique · IPA URG

♠ D

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

R ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Colique néphrétique

Compétences IPA : C1

> *M. N., 35 ans, consulte pour une douleur lombaire droite brutale et intense, irradiant vers l'aine.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Siège, irradiation, intensité de la douleur
- Fièvre, signes urinaires
- Antécédents de lithiase
- Fonction rénale connue, rein unique
- Grossesse (chez une femme)

Raisonnement clinique · IPA URG

R ♥

R ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Colique néphrétique

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. N., 35 ans, consulte pour une douleur lombaire droite brutale et intense, irradiant vers l'aine.

> *Patient agité, sans fièvre.*

? Quelle hypothèse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Colique néphrétique simple
- Formes compliquées : fébrile, anurique, hyperalgique
- Différentiels : appendicite ; dissection aortique après 50 ans
- Évaluation de la douleur

Raisonnement clinique · IPA URG

R ♦

R ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Colique néphrétique

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. N., 35 ans, consulte pour une douleur lombaire droite brutale et intense, irradiant vers l'aine.

> *Vous complétez le bilan.*

? Quels examens ?

REPÈRES ATTENDUS

- Bandelette urinaire
- Créatinine
- Imagerie : scanner sans injection ou échographie
- Température

Raisonnement clinique · IPA URG

R ♣

R ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Colique néphrétique

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. N., 35 ans, consulte pour une douleur lombaire droite brutale et intense, irradiant vers l'aine.

> *Colique néphrétique simple.*

? Quelle prise en charge ?

REPÈRES ATTENDUS

- AINS en 1re intention si pas de contre-indication
- Filtrer les urines
- Signes d'alerte : fièvre, anurie
- Consultation urologique selon la taille du calcul
- Hydratation

Raisonnement clinique · IPA URG

R ♠

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Passages répétés : parcours

Compétences IPA : C1

> *Mme H., 66 ans, BPCO, consulte pour la quatrième fois en 2 mois aux urgences pour dyspnée.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Motifs des passages
- Suivi médical en ville
- Traitements, observance
- Contexte social
- Compréhension de la maladie

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Passages répétés : parcours

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme H., 66 ans, BPCO, consulte pour la quatrième fois en 2 mois aux urgences pour dyspnée.

> *Elle n'a pas de médecin traitant.*

? Quels problèmes identifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Absence de parcours de soins
- Maladie chronique non suivie
- Risque d'hospitalisations répétées
- Vulnérabilité sociale

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Passages répétés : parcours

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme H., 66 ans, BPCO, consulte pour la quatrième fois en 2 mois aux urgences pour dyspnée.

> *Vous évaluez sa situation.*

? Quelles évaluations ?

REPÈRES ATTENDUS

- Évaluation respiratoire
- Évaluation sociale
- Revue des traitements
- Ressources locales disponibles

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Passages répétés : parcours

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme H., 66 ans, BPCO, consulte pour la quatrième fois en 2 mois aux urgences pour dyspnée.

> *Elle souhaite être suivie.*

? Comment organisez-vous le parcours ?

REPÈRES ATTENDUS

- Recherche d'un médecin traitant, lien avec la CPTS
- Lien avec le dispositif d'appui à la coordination (DAC)
- Éducation thérapeutique
- Plan d'action écrit
- Suivi du nombre de passages (indicateur)

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

JOKER

JOKER 1

Drapeau rouge

Choisissez une situation du jeu et citez au moins deux signes d'alerte qui imposent une orientation urgente.

Si le groupe valide, ce joker remplace n'importe quelle carte manquante d'un carré.

JOKER

JOKER

JOKER 2

Leadership & recherche

À partir de la dernière situation jouée, proposez une action d'amélioration des pratiques (protocole, audit, formation) ou formulez une question de recherche (PICO).

Compétences C5 · C6. Si le groupe valide, ce joker remplace une carte manquante d'un carré.

JOKER

Aide-mémoire · les couleurs

Chaque couleur est une étape du raisonnement.

♥ **Cœur · Recueillir**
Anamnèse, écoute, contexte de vie

♦ **Carreau · Repérer & hypothèses**
Repérage, scores, hypothèses et drapeaux rouges

♣ **Trèfle · Vérifier**
Examen clinique, examens complémentaires, diagnostics différentiels

♠ **Pique · Agir & suivre**
Projet de soins, prévention, ETP, parcours et coordination

Un **carré** (les 4 couleurs d'une même valeur) = un raisonnement complet sur un même patient.

Aide-mémoire · les thématiques

Chaque valeur suit un même patient à travers les 4 étapes.

2	Douleur thoracique
3	Traumatisme de la cheville
4	Plaie de la main
5	Céphalée brutale
6	Lombalgie aiguë
7	Infection urinaire
8	Traumatisme crânien sous anticoagulant
9	Brûlure
10	Asthme aigu
V	Chute de la personne âgée
D	Intoxication alcoolique aiguë
R	Colique néphrétique
A	Passages répétés : parcours

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · URG

IPA · Master